جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : احمد حسن عابد حسن
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** البدرشين **العنوان :** مزغونة
رقم البطاقة : 27709232100738 **رقم التليفون :** 01235468526 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 23-09-1977 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : اورام ليمفاويه
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : اورام ليمفاويه
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [6930] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: احمد حسن عابد حسن
National ID: 27709232100738

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

A patient of lymphoma for Further investigations and imaging

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية



احمد

حسن عايد حسن

مزغونه

مركز البدرشين - الجيزه

٢٧٧٠٩٢٣٢١٠٠٧٣٨

LF1933147



٢٧٧٠٩٢٣٢١٠٠٧٣٨ ٢٠٢٥/٠٦

بدون عمل

ذكر مسلم متزوج

١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٦/١٧

National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL EGYPT

Patient Name	: [illegible]	Request No.	: 13009123
Patient No.	: 27709232100738	Request Date	: 31/07/2025
Path No.	: SR-1055/25	Verification Date	: 23/08/2025
Sex	: Male	Financial Category	: جوستاف روسي - نقدية اجنبية
Age	: 47 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Diagnosis

Right axillary lymphadenopathy, slide&block revision :

Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma.

Signature

Prof. Dr. Gamal Abdelatty

Dr.Menan Hosam .

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Room No. (1) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mar El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: احمد حسن عابد **MR. :** 1037	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

ACASE NODULAR sclerosis Hodgkin lymphoma received 3cycles CHOP Interim PET CT regressive coarse THEN 3 CYCLES CHOP Last PET CT pending.

A case of NLPHL s/p 6 cycles of CHOP, with intial PR after 3 cycles then PD after 3 more. For ICE X 4 then new PET then ASCT.

To start cycel 1 ICE after labs. Progressed as stage 3b disease.

In view of shortage of holoxan to start first cycle GDP

clinical pharmacy note : wt 95 ht 175 sa 2 for d1 and d8 gemzar 2000 mg cisplatin 75 mg

For C1D8 gemzar 1gm/m2 after labs with oral formulated mouth wash.

Marked improvment of the general condition for C2 ICE with oral augmentin & mouth wash for pharyngitis which improved markedly

PET CT 11/7/2026 total resolution of supra and infradiaphragmatic LN apart from few metabolically active rt axillary Ln 2cm suv 6.5 was 4.1*2.7cm suv 17 .

Patient referred for palliative radiotherapy didn't go yet mean while for C4 ICE

pharmacy visit: for ICE C5 + mabthera 500mg today

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : هاجر حمدي عبدالهادي محمود

يعتمد ,

SUVmax~14, while the most active is seen at retro-caval group measuring 2x1.8 cm with SUVmax~16.9.
- No FDG avid lung nodules or masses detected.
- Bilateral pulmonary scattered atelectatic bands.
- No metabolically active pericardial or pleural lesions detected.
- Physiologic FDG uptake is noted in the heart.

Abdomen and Pelvis:
- Average sized spleen with increased heterogenous FDG uptake of SUVmax~7.2 at its lower pole, likely infiltrated.
- Few low grade FDG avid porta-hepatic lymph nodes reaching 1.7 cm with SUVmax~3.3
- Physiologic diffuse FDG uptake is seen over average sized liver. No FDG avid focal lesions detected
- Physiologic diffuse FDG uptake is seen over average sized spleen with homogenous parenchymal texture and no FDG avid focal lesions seen.
- Normal appearance of both kidneys with no stones or back-pressure changes. Physiologic FDG excretion is seen in the kidneys and bladder.
- Normal appearance of the pancreas and both supra-renal with no FDG avid lesions detected.
- No evidence of ascites or abdominal collections noted.

Musculoskeletal:
- Diffusely activated bone marrow with low grade FDG uptake, likely reactive for lab correlation.
- Few small non FDG avid left femoral and pelvic bones sclerotic osseous lesions, likely bone islands.
- No focal active blastic or lytic bone lesions detected.

Conclusion:
FDG PET/CT study for a known case of HL revealed;
- Multiple FDG avid supra-diaphragmatic lymphomatous nodal lesions.
- Few low grade metabolically active upper abdominal lymph nodes for close follow up.
- Average sized spleen with increased heterogenous FDG uptake as described, likely lymphomatous infiltration.

Reported By,
Dr. Mohamed Abdeltawab ,MSc
Dr. Mohamed Mohsen, MD
Ass. Prof. Mai Amr, Nuclear Medicine Consultant 30-Jul-2025 10:22 AM

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
احمد
حسن عابد حسن
مزغونه
مركز البدرشين - الجيزه
٢٧٧٠٩٢٣٢١٠٠٧٣٨
LF1933147


ERM036748742


٢٧٧٠٩٢٣٢١٠٠٧٣٨
٢٠٢٥/٠٦
بدون عمل
ذكر
مسلم
متزوج
١
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٦/١٧

جوستاف روسي
للأبحاث السرطان
مصر

إسم المريض ثلاثي: [illegible] عابد
رقم الملف: ٥٥٠١٩٠/٢٥

اوامر الطبيب Doctor's Orders

التشخيص: NLPHL نوع التغذية :.....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		Pt. i.c.d. : Stage IIB cervical, SCLN Axillary, mediastinal, Abdominal & Spleen pathology :- N.L.P.H.L CD20 tve, CD3 +ve CD5 -ve Bcl2 KI67 20% CD30 & CD15 → -ve ECHO :- 59% virology :- H.I.V 1&2 -ve HBsAg -ve HCV AB For CHOP 3cycles then reassess full labs	4/9/2025

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

PATIENT NAME: AHMED HASSAN ABED HASSAN
GENDER: Male
DATE : 29-Jul-2025 11:35 AM

PATIENT ID: 10125267832
AGE: 47 y
ORDER: 3492571

Whole body [18F] FDG PET-CT Scan

CLINICAL HISTORY:
-47 years old male patient, presented with recently diagnosed HL.
Reason for the study: detection of FDG avid lymphomatous lesions.

TECHNIQUE:

- **Radiopharmaceutical**: 18F FDG, intravenously.
- **Time from 18F-FDG injection to scan:**60 min
- **PET/CT images** were acquired from the skull through the upper thighs & **CT images** were acquired for the purpose of anatomical localization and attenuation correction. Images were reviewed in the transaxial, coronal, and sagittal planes.
- **Patient's weight:** Kg - **Patient's height:** cm -**Bl. Gluc. Level:** mg/dL
- **Additional notes:** SUV max normalized to body weight was used.
- **Reference hepatic activity (SUV max): 2.7**
- **Reference mediastinal blood pool activity (SUV max): 2**

FINDINGS:

Head and Neck:

- **Multiple FDG avid right lower cervical and right supra-clavicular lymph nodes (levels III, IV and Vb) reaching 1.8x2.2 cm with SUVmax~13.8 at the latter group.**
- Normal diffuse brain activity with no hypermetabolic brain lesions.
- Physiologic FDG uptake is seen in the nasopharynx, oropharynx, salivary glands and larynx.
- Physiologic FDG uptake is seen in submandibular and parotid salivary glands.
- Normal appearance of thyroid gland with no FDG avid nodules detected.

Chest:

- **Multiple FDG avid right axillary lymph nodes (all levels), reaching 4.5x3.3 cm with SUVmax~14.6**
- **Multiple FDG avid mediastinal right para-tracheal, retro-caval, pre-vascular, posterior mediastinal, carinal and sub-carinal lymph nodes, the largest is seen at the sub-carinal group measuring 3.3x2.3 cm with**

www.Baheya.org
16602
مركز بهية الهرم
٨ شارع علوية أول شارع الهرم بجوار داوي . الجيزة
مستشفى بهية الشيخ زايد
٤ الحي الأول - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة

SUVmax~14, while the most active is seen at retro-caval group measuring 2x1.8 cm with SUVmax~16.9.

- No FDG avid lung nodules or masses detected.
- Bilateral pulmonary scattered atelectatic bands.
- No metabolically active pericardial or pleural lesions detected.
- Physiologic FDG uptake is noted in the heart.

Abdomen and Pelvis:

- **Average sized spleen with increased heterogenous FDG uptake of SUVmax~7.2 at its lower pole, likely infiltrated.**
- **Few low grade FDG avid porta-hepatic lymph nodes reaching 1.7 cm with SUVmax~3.3**
- Physiologic diffuse FDG uptake is seen over average sized liver. No FDG avid focal lesions detected
- Physiologic diffuse FDG uptake is seen over average sized spleen with homogenous parenchymal texture and no FDG avid focal lesions seen.
- Normal appearance of both kidneys with no stones or back-pressure changes. Physiologic FDG excretion is seen in the kidneys and bladder.
- Normal appearance of the pancreas and both supra-renal with no FDG avid lesions detected.
- No evidence of ascites or abdominal collections noted.

Musculoskeletal:

- Diffusely activated bone marrow with low grade FDG uptake, likely reactive for lab correlation.
- Few small non FDG avid left femoral and pelvic bones sclerotic osseous lesions, likely bone islands.
- No focal active blastic or lytic bone lesions detected.

Conclusion:

FDG PET/CT study for a known case of HL revealed;

- **Multiple FDG avid supra-diaphragmatic lymphomatous nodal lesions.**
- **Few low grade metabolically active upper abdominal lymph nodes for close follow up.**
- **Average sized spleen with increased heterogenous FDG uptake as described, likely lymphomatous infiltration.**

Reported By,
Dr. Mohamed Abdeltawab ,MSc
Dr. Mohamed Mohsen, MD
Ass. Prof. Mai Amr, Nuclear Medicine Consultant **30-Jul-2025 10:22 AM**

www.Baheya.org 16602
مركز بهية الهرم
٩ شارع علوية أول شارع الهرم بجوار داري , الجيزة
مستشفى بهية الشيخ زايد
٤٠ الحي الأول - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL EGYPT

Patient Name	: الاستاذ / احمد حسن عابد حسن	Request No.	: 13009129
Patient No.	: 27709232100738	Request Date	: 31/07/2025
Path No.	: SR-1055/25	Verification Date	: 23/08/2025
Sex	: Male	Financial Category	جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 47 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data
Right axillary lymphadenopathy .

Nature of specimen
Block &slide revision .

Gross specimen
One block and 8 slides labelled by (3307-25) were received .
Technique:
- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibod es using ultra view HRP DAB as chromogen and hematcxylin as counter stain. The sections treated against BCL-6clone(G/191E/A8), OCT2.CD15 (MMA)CD15 clone(MMA)CD4 clone (SP35).

Microscopic examination
Examination revealed effacement of nodular architecture by vague nodules formed of large atypical cells with background of mixed inflammatory infiltrate .
IPT :
CD20:Positive in few collections
CD3:Positive in many small cells
CD5 :Positive in many small cells
CD4:Positive in many small cells .
KI67 :20 %
BCL2 :Few small collections of cells.
BCL6 :Present in individual large cells .
OCT2 :Present in indvidual large cells .
CD30 :Negative.
CD15 : Negative .

Verified by :
Dr.Heba Hasan

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL EGYPT

Patient Name	: الاستاذ / احمد حسن عابد حسن	Request No.	: 13009129
Patient No.	: 27709232100735	Request Date	: 31/07/2025
Path No.	: SR-1055/25	Verification Date	: 23/08/2025
Sex	: Male	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 47 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Diagnosis
Right axillary lymphadenopathy, slide&block revision :
Nodular lymphocytic predominant Hodgkin lymphoma.

Signature
Prof. Dr. Gamal Abdelatty
Dr.Menan Hosam .

Verified by :
Dr.Heba Hasan

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

د. جمال سالم د. أحمد جمال سالم
أخصائيين التحاليل الطبيه
دبلومة الكيمياء الحيويه والميكروبيولوجي التطبيقية
ماجستير الكيمياء الحيويه جامعة القاهره

معمل الفيروز
للتحاليل الطبية وأبحاث الدم

Patient Name	الاستاذ / احمد حسن عابد	Request Date :	07/07/2025 07:34:35 م
Gender/Age	Male - 47 Years	Reporting Date :	07/07/2025 11:02:29 م
Referred By	أ.د/ عمر رضا فتيح		

20257755246

Laboratory Report

Test	Result	Unit	Reference Range
Blood Glucose			
- Random Blood Sugar	81	mg/dl	60 - 160
Hepatitis Markers			
- HIV 1+2+O Ab.	Negative		Negative
- HBsAg	Negative		Negative
- HCV antibodies	Negative		Negative
LIVER FUNCTIONS			
- Serum GPT (ALT) ↑	48	U/L	0 - 40
COAGULATION			
- Patient time	13.00	%	12 - 16
- Control time	13		13
- Patient Concentration	100		70 - 110
- INR	1		1 - 1.3
- Ratio	1		
KIDNEY FUNCTIONS			
- Creatinine (Serum)	0.93	mg/dL	0.5 - 1.3

Doctor Signature

01146366612 - 01123229180
العنوان : دهشور - برج الأطباء


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
احمد
حسن عابد حسن
مزغونه
مركز البدرشين - الجيزه
٢٧٧٠٩٢٣٢١٠٠٧٣٨
LF1933147


ERM036748742


٢٧٧٠٩٢٣٢١٠٠٧٣٨
٢٠٢٥/٠٦
بدون عمل
ذكر
مسلم
متزوج
١
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٦/١٧

جوستاف روسي
للأبحاث السرطان
مصر

إسم المريض ثلاثي: [illegible] عابد
رقم الملف: ٥٥٠١٩٠/٢٥

اوامر الطبيب Doctor's Orders

التشخيص: NLPHL نوع التغذية :.....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		Pt. i.c.d. : Stage IIB cervical, SCLN Axillary, mediastinal, Abdominal & Spleen pathology :- N.L.P.H.L CD20 tve, CD3 +ve CD5 -ve Bcl2 KI67 20% CD30 & CD15 → -ve ECHO :- 59% virology :- H.I.V 1&2 -ve HBsAg -ve HCV AB For CHOP 3cycles then reassess full labs	4/9/2025

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

PATIENT NAME: AHMED HASSAN ABED HASSAN
GENDER: Male
DATE : 29-Jul-2025 11:35 AM

PATIENT ID: 10125267832
AGE: 47 y
ORDER: 3492571

Whole body [18F] FDG PET-CT Scan

CLINICAL HISTORY:
-47 years old male patient, presented with recently diagnosed HL.
Reason for the study: detection of FDG avid lymphomatous lesions.

TECHNIQUE:

- **Radiopharmaceutical**: 18F FDG, intravenously.
- **Time from 18F-FDG injection to scan:**60 min
- **PET/CT images** were acquired from the skull through the upper thighs & **CT images** were acquired for the purpose of anatomical localization and attenuation correction. Images were reviewed in the transaxial, coronal, and sagittal planes.
- **Patient's weight:** Kg - **Patient's height:** cm -**Bl. Gluc. Level:** mg/dL
- **Additional notes:** SUV max normalized to body weight was used.
- **Reference hepatic activity (SUV max): 2.7**
- **Reference mediastinal blood pool activity (SUV max): 2**

FINDINGS:

Head and Neck:

- **Multiple FDG avid right lower cervical and right supra-clavicular lymph nodes (levels III, IV and Vb) reaching 1.8x2.2 cm with SUVmax~13.8 at the latter group.**
- Normal diffuse brain activity with no hypermetabolic brain lesions.
- Physiologic FDG uptake is seen in the nasopharynx, oropharynx, salivary glands and larynx.
- Physiologic FDG uptake is seen in submandibular and parotid salivary glands.
- Normal appearance of thyroid gland with no FDG avid nodules detected.

Chest:

- **Multiple FDG avid right axillary lymph nodes (all levels), reaching 4.5x3.3 cm with SUVmax~14.6**
- **Multiple FDG avid mediastinal right para-tracheal, retro-caval, pre-vascular, posterior mediastinal, carinal and sub-carinal lymph nodes, the largest is seen at the sub-carinal group measuring 3.3x2.3 cm with**

www.Baheya.org
16602
مركز بهية الهرم
٨ شارع علوية أول شارع الهرم بجوار داوي . الجيزة
مستشفى بهية الشيخ زايد
٤ الحي الأول - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة

SUVmax~14, while the most active is seen at retro-caval group measuring 2x1.8 cm with SUVmax~16.9.

- No FDG avid lung nodules or masses detected.
- Bilateral pulmonary scattered atelectatic bands.
- No metabolically active pericardial or pleural lesions detected.
- Physiologic FDG uptake is noted in the heart.

Abdomen and Pelvis:

- **Average sized spleen with increased heterogenous FDG uptake of SUVmax~7.2 at its lower pole, likely infiltrated.**
- **Few low grade FDG avid porta-hepatic lymph nodes reaching 1.7 cm with SUVmax~3.3**
- Physiologic diffuse FDG uptake is seen over average sized liver. No FDG avid focal lesions detected
- Physiologic diffuse FDG uptake is seen over average sized spleen with homogenous parenchymal texture and no FDG avid focal lesions seen.
- Normal appearance of both kidneys with no stones or back-pressure changes. Physiologic FDG excretion is seen in the kidneys and bladder.
- Normal appearance of the pancreas and both supra-renal with no FDG avid lesions detected.
- No evidence of ascites or abdominal collections noted.

Musculoskeletal:

- Diffusely activated bone marrow with low grade FDG uptake, likely reactive for lab correlation.
- Few small non FDG avid left femoral and pelvic bones sclerotic osseous lesions, likely bone islands.
- No focal active blastic or lytic bone lesions detected.

Conclusion:

FDG PET/CT study for a known case of HL revealed;

- **Multiple FDG avid supra-diaphragmatic lymphomatous nodal lesions.**
- **Few low grade metabolically active upper abdominal lymph nodes for close follow up.**
- **Average sized spleen with increased heterogenous FDG uptake as described, likely lymphomatous infiltration.**

Reported By,
Dr. Mohamed Abdeltawab ,MSc
Dr. Mohamed Mohsen, MD
Ass. Prof. Mai Amr, Nuclear Medicine Consultant **30-Jul-2025 10:22 AM**

www.Baheya.org 16602
مركز بهية الهرم
٩ شارع علوية أول شارع الهرم بجوار داري , الجيزة
مستشفى بهية الشيخ زايد
٤٠ الحي الأول - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL EGYPT

Patient Name	: الاستاذ / احمد حسن عابد حسن	Request No.	: 13009129
Patient No.	: 27709232100738	Request Date	: 31/07/2025
Path No.	: SR-1055/25	Verification Date	: 23/08/2025
Sex	: Male	Financial Category	جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 47 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data
Right axillary lymphadenopathy .

Nature of specimen
Block &slide revision .

Gross specimen
One block and 8 slides labelled by (3307-25) were received .
Technique:
- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibod es using ultra view HRP DAB as chromogen and hematcxylin as counter stain. The sections treated against BCL-6clone(G/191E/A8), OCT2.CD15 (MMA)CD15 clone(MMA)CD4 clone (SP35).

Microscopic examination
Examination revealed effacement of nodular architecture by vague nodules formed of large atypical cells with background of mixed inflammatory infiltrate .
IPT :
CD20:Positive in few collections
CD3:Positive in many small cells
CD5 :Positive in many small cells
CD4:Positive in many small cells .
KI67 :20 %
BCL2 :Few small collections of cells.
BCL6 :Present in individual large cells .
OCT2 :Present in indvidual large cells .
CD30 :Negative.
CD15 : Negative .

Verified by :
Dr.Heba Hasan

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL EGYPT

Patient Name	: الاستاذ / احمد حسن عابد حسن	Request No.	: 13009129
Patient No.	: 27709232100735	Request Date	: 31/07/2025
Path No.	: SR-1055/25	Verification Date	: 23/08/2025
Sex	: Male	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 47 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Diagnosis
Right axillary lymphadenopathy, slide&block revision :
Nodular lymphocytic predominant Hodgkin lymphoma.

Signature
Prof. Dr. Gamal Abdelatty
Dr.Menan Hosam .

Verified by :
Dr.Heba Hasan

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

د. جمال سالم د. أحمد جمال سالم
أخصائيين التحاليل الطبيه
دبلومة الكيمياء الحيويه والميكروبيولوجي التطبيقية
ماجستير الكيمياء الحيويه جامعة القاهره

معمل الفيروز
للتحاليل الطبية وأبحاث الدم

Patient Name	الاستاذ / احمد حسن عابد	Request Date :	07/07/2025 07:34:35 م
Gender/Age	Male - 47 Years	Reporting Date :	07/07/2025 11:02:29 م
Referred By	أ.د/ عمر رضا فتيح		

20257755246

Laboratory Report

Test	Result	Unit	Reference Range
Blood Glucose			
- Random Blood Sugar	81	mg/dl	60 - 160
Hepatitis Markers			
- HIV 1+2+O Ab.	Negative		Negative
- HBsAg	Negative		Negative
- HCV antibodies	Negative		Negative
LIVER FUNCTIONS			
- Serum GPT (ALT) ↑	48	U/L	0 - 40
COAGULATION			
- Patient time	13.00	%	12 - 16
- Control time	13		13
- Patient Concentration	100		70 - 110
- INR	1		1 - 1.3
- Ratio	1		
KIDNEY FUNCTIONS			
- Creatinine (Serum)	0.93	mg/dL	0.5 - 1.3

Doctor Signature

01146366612 - 01123229180
العنوان : دهشور - برج الأطباء

Medical No. : 10605
Patient's Name: Ahmed Hassan Abed
Date: 2026-09-29
Referred by: Prof.Dr. **no doctor**
Hospital: **Goustave Roussey International Egypt**

MULTISLICE NON-CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST:

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the chest with multiplanar reconstruction. No IV contrast was used.

FINDINGS:

- Bilateral fibrotic parenchymal bands.
- no sizable pulmonary nodules, consolidation or cavitation.
- No pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No plural or pericardial collection.
- No gross cardiomegaly
- Upper abdominal cuts show fatty liver

Opinion: -

- **Unremarkable CT study of chest.**

Dr.Nourhan Ewis

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]